



Hemorragia Digestiva: HDA Varicosa, HDB e HDM

Apostila de Especialização — Parte 3 (Páginas 121–180). Este módulo aborda de forma integrada as hemorragias digestivas de origem varicosa, baixa e média, com ênfase no raciocínio clínico estruturado, nas condutas baseadas em evidências e na tomada de decisão em cenários de urgência.

MÓDULO 3

GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA

Estrutura do Módulo

O Que Você Vai Aprender

Este módulo é estruturado em três grandes eixos temáticos, culminando com a aplicação prática por meio de casos clínicos e raciocínio avançado do especialista.

01

HDA Varicosa

Fisiopatologia da hipertensão portal, formação de varizes, abordagem clínica e endoscópica, terapia vasoativa, antibioticoprofilaxia e manejo das falhas terapêuticas.

03

Hemorragia Digestiva Média (HDM)

Origem no intestino delgado, cápsula endoscópica, enteroscopia e manejo do sangramento obscuro.

02

Hemorragia Digestiva Baixa (HDB)

Causas mais frequentes — doença diverticular, angiodisplasia, neoplasias e colites —, diagnóstico colonoscópico e estratégias de hemostasia endoscópica.

04

Casos Clínicos e Raciocínio Avançado

Aplicação prática, fluxo mental do especialista, erros a evitar e visão sistêmica integrada da hemorragia digestiva como emergência multidisciplinar.

CAPÍTULO 1

Hemorragia Digestiva Alta Varicosa

A HDA varicosa representa uma das emergências gastroenterológicas mais graves e de maior mortalidade. Compreender seus mecanismos, estratificação de risco e conduta sistematizada é essencial para o especialista.



HDA Varicosa — Introdução e Relevância Clínica

Por que é tão grave?

A HDA varicosa é responsável por uma parcela expressiva das internações por sangramento digestivo em pacientes cirróticos. A mortalidade pode atingir **20–30% no primeiro episódio**, elevando-se progressivamente com cada ressangramento. A gravidade decorre não apenas do volume de sangue perdido, mas da disfunção hepática subjacente, da coagulopatia e da predisposição a infecções.

Causas Principais

A HDA varicosa está diretamente associada à **hipertensão portal**, condição que leva ao desenvolvimento de circulações colaterais portossistêmicas. As duas fontes de sangramento mais relevantes são:

- **Varizes esofágicas:** presentes em cerca de 50% dos cirróticos; rompem com frequência na junção esofagogástrica.
- **Varizes gástricas:** menos frequentes, porém associadas a sangramentos mais volumosos e de difícil controle endoscópico.

A identificação da fonte é fundamental para direcionar o tratamento específico e os procedimentos de hemostasia.

Fisiopatologia da Hipertensão Portal

A hipertensão portal é definida pelo aumento do gradiente de pressão venosa hepática (GPVH) acima de **5 mmHg**. Resulta fundamentalmente de dois mecanismos que se somam e se potencializam:

Aumento da Resistência Intra-hepática

Na cirrose, a fibrose hepática e os nódulos de regeneração comprimem os sinusoides e os vasos portais intra-hepáticos, elevando a resistência mecânica ao fluxo. Além disso, há contração ativa de células estreladas e miofibroblastos, componente dinâmico e potencialmente reversível.

Aumento do Fluxo Esplâncnico

Em resposta à hipertensão portal, há vasodilatação esplâncnica mediada por óxido nítrico e outros vasodilatadores endógenos. Isso aumenta o volume sanguíneo que chega ao sistema porta, agravando ainda mais a pressão.

Formação de Colaterais Portossistêmicas

Quando a pressão portal supera a sistêmica, o sangue desvia por vias colaterais: veias esofágicas, gástricas, retroperitoneais e hemorroidárias. Essas colaterais são responsáveis pelas varizes e pelo risco de ruptura.

Formação e Ruptura das Varizes

Limiar de Pressão para Formação

As varizes esofágicas e gástricas se desenvolvem quando o **GPVH ultrapassa 10–12 mmHg**. Abaixo desse limiar, o risco de formação é mínimo. Para que haja ruptura e sangramento, o gradiente geralmente precisa estar acima de **12 mmHg** — esse é o valor crítico monitorado na prática clínica.

Locais Mais Acometidos

- **Esôfago distal:** região de maior vulnerabilidade, onde a parede venosa é mais delgada e o fluxo mais turbulento.
- **Fundo gástrico:** varizes fundicas são frequentemente alimentadas por vasos de grosso calibre e têm parede mais friável.

Mecanismo da Ruptura

A ruptura das varizes é precipitada por eventos que aumentam abruptamente a pressão intravascular:

- Esforço físico intenso ou manobra de Valsalva
- Ingesta de bebida alcoólica
- Infecção (especialmente PBE)
- Variações hemodinâmicas bruscas

A parede das varizes segue a **Lei de Laplace**: quanto maior o raio do vaso e maior a pressão transmural, maior a tensão na parede — e o risco de ruptura aumenta exponencialmente com o tamanho da variz.

Fatores de Risco para Sangramento Varicoso

A estratificação de risco de sangramento é essencial para definir a necessidade de profilaxia primária e a urgência da intervenção endoscópica.



Tamanho das Varizes

Varizes de grande calibre (>5 mm) têm maior tensão parietal e risco de ruptura significativamente elevado. A classificação endoscópica em pequenas, médias e grandes orienta diretamente a indicação de profilaxia.



Sinais Vermelhos (Red Signs)

Achados endoscópicos como *red wale marks*, *cherry red spots* e *hematocystic spots* indicam tensão parietal elevada e risco iminente de sangramento, independentemente do tamanho da variz.



Classe Child-Pugh

Pacientes Child B e C têm disfunção hepática mais grave, coagulopatia e maior pressão portal, o que amplifica o risco de sangramento e piora o prognóstico após o episódio hemorrágico.

Classificação de Child-Pugh

A classificação de Child-Pugh é um dos principais instrumentos para avaliar a gravidade da hepatopatia crônica e estratificar o prognóstico de pacientes cirróticos. É baseada em cinco parâmetros clínico-laboratoriais, cada um pontuado de 1 a 3:

Parâmetro	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Bilirrubina total (mg/dL)	<2	2-3	>3
Albumina (g/dL)	>3,5	2,8-3,5	<2,8
Tempo de protrombina (seg.)	<4	4-6	>6
Ascite	Ausente	Leve/moderada	Tensa
Encefalopatia	Ausente	Grau I-II	Grau III-IV

Child A (5-6 pontos)

Cirrose leve. Mortalidade cirúrgica estimada em 5-10%. Melhor prognóstico.

Child B (7-9 pontos)

Cirrose moderada. Mortalidade cirúrgica em torno de 20-30%. Risco intermediário.

Child C (10-15 pontos)

Cirrose grave. Mortalidade cirúrgica acima de 70-80%. Alto risco de sangramento fatal e mau prognóstico global.

Mortalidade na HDA Varicosa

A hemorragia varicosa permanece uma condição de alta letalidade, mesmo com os avanços terapêuticos das últimas décadas. Os dados epidemiológicos são alarmantes e reforçam a necessidade de abordagem rápida e sistematizada.

20–30%

Mortalidade no Primeiro Episódio

Taxa de mortalidade intra-hospitalar no primeiro sangramento varicoso, mesmo com tratamento adequado.

70%

Mortalidade Child C

Pacientes Child-Pugh C com sangramento ativo têm mortalidade em 6 semanas que pode superar 70% sem intervenção precoce.

60%

Ressangramento sem Profilaxia

Sem profilaxia secundária, até 60% dos pacientes ressangram no prazo de um ano após o primeiro episódio.

📌 **Ponto crítico:** O ressangramento precoce (primeiros 5 dias) é o principal preditor de mortalidade. A falha em controlar o sangramento nas primeiras 24h deve acionar protocolo de escalonamento terapêutico imediato.

Apresentação Clínica da HDA Varicosa

Sinais e Sintomas Típicos

- **Hematêmese volumosa:** vômitos com sangue vivo ou em "borra de café"; frequentemente copiosa, assustando o paciente e os familiares. É o sintoma mais característico.
- **Melena:** fezes negras, pastosas e fétidas, indicando sangramento alto com trânsito intestinal. Pode acompanhar a hematêmese ou ser o sintoma inicial.
- **Hematoquezia:** menos comum, mas pode ocorrer em sangramentos de grande volume com trânsito acelerado.

Repercussões Sistêmicas

- **Hipotensão e taquicardia:** sinais de instabilidade hemodinâmica que indicam perda volêmica significativa.
- **Choque hipovolêmico:** palidez, sudorese fria, confusão mental e oligúria em casos graves.
- **Encefalopatia hepática:** pode ser precipitada pelo sangramento digestivo por aumento da carga de nitrogênio intestinal e piora da função hepática.

A combinação de **cirrose conhecida + hematêmese volumosa** deve acionar imediatamente o protocolo de HDA varicosa, sem aguardar confirmação endoscópica.

Abordagem Inicial — Medidas Gerais

O manejo inicial da HDA varicosa segue os princípios do suporte avançado de vida, com atenção às peculiaridades do paciente cirrótico. Cada minuto conta na redução da mortalidade.



A abordagem deve ser simultânea e não sequencial: enquanto se obtém acesso venoso e se inicia a reposição volêmica, a terapia vasoativa e os antibióticos devem ser prescritos. O pedido de endoscopia urgente deve ser feito no mesmo momento.

Acesso Venoso e Monitorização

- Dois acessos venosos periféricos calibrosos ($\geq 16G$) ou acesso venoso central
- Monitorização contínua: PA, FC, SpO_2 , débito urinário
- Intubação orotraqueal profilática em pacientes com encefalopatia ou risco de aspiração

Reposição Volêmica Cautelosa

- Evitar sobrecarga hídrica: soro fisiológico com moderação
- Sobrecarga aumenta pressão portal e favorece ressangramento
- Albumina pode ser considerada em pacientes com ascite associada
- Coloides com cautela em cirróticos avançados

Transfusão Restritiva na HDA Varicosa

Meta Transfusional

A estratégia restritiva de transfusão é fortemente recomendada pelas diretrizes internacionais (Baveno VII). A meta é manter a **hemoglobina entre 7 e 9 g/dL**, evitando transfusão desnecessária.

Estudo de Villanueva et al. (NEJM, 2013) demonstrou que a estratégia restritiva reduziu mortalidade em 45 dias (5% vs. 9%) e ressangramento (10% vs. 16%) em comparação com estratégia liberal em pacientes com HDA varicosa.

Por que evitar transfusão excessiva?

- **Aumento da volemia:** eleva a pressão venosa portal, distendendo as varizes e aumentando o risco de ressangramento.
- **Piora da hipertensão portal:** especialmente em cirróticos com circulação hiperdinâmica.
- **Coagulopatia dilucional:** transfusões maciças alteram o equilíbrio hemostático já frágil do cirrótico.
- **Reações transfusionais:** risco adicional em pacientes criticamente enfermos.

❏ **Exceção:** Pacientes com doença coronariana, insuficiência cardíaca ou instabilidade hemodinâmica grave podem necessitar de meta mais liberal (Hb >9 g/dL).

Antibioticoprofilaxia na Cirrose com Sangramento

A antibioticoprofilaxia é uma medida de eficácia bem estabelecida e deve ser iniciada imediatamente ao diagnóstico de sangramento em pacientes cirróticos, independentemente do local de sangramento. Trata-se de uma recomendação universal, com nível de evidência A.

Racional Fisiopatológico

Pacientes cirróticos com hemorragia digestiva apresentam translocação bacteriana aumentada, especialmente de bactérias gram-negativas entéricas. A bacteremia subsequente precipita infecções como PBE, pneumonia e infecções urinárias, que por sua vez aumentam a pressão portal e o risco de ressangramento.

Benefícios Comprovados

- Redução da taxa de infecção bacteriana em até 50%
- Redução do ressangramento precoce
- Redução da mortalidade em 6 semanas
- Menor tempo de internação em UTI

Duração do Tratamento

O curso de antibioticoprofilaxia deve ter duração de **5 a 7 dias**. Após esse período, a antibioticoterapia de longa duração pode ser avaliada individualmente em pacientes de alto risco (Child C, PBE prévia).

Antibióticos Utilizados na Profilaxia

Ceftriaxona (1ª Escolha)

A ceftriaxona IV é a opção preferencial na maioria dos centros e nas diretrizes atuais (Baveno VII), especialmente em:

- Pacientes com cirrose avançada (Child B/C)
- Hospitais com alta prevalência de resistência a quinolonas
- Pacientes em uso prévio de norfloxacino profilático
- Ambiente hospitalar (preferência à via IV)

Dose: 1 g IV a cada 24 horas por 5–7 dias.

Norfloxacino (Alternativa Oral)

O norfloxacino oral foi a primeira opção por muitos anos e ainda é utilizado em centros com baixa prevalência de resistência a quinolonas ou quando a via oral é viável:

- Pacientes com cirrose leve a moderada (Child A/B)
- Ausência de resistência local a quinolonas
- Disponibilidade da via oral

Dose: 400 mg VO a cada 12 horas por 7 dias.

❏ A escolha entre ceftriaxona e norfloxacino deve considerar o perfil local de resistência antimicrobiana. Em muitos centros brasileiros, a ceftriaxona é a primeira escolha.

Terapia Vasoativa — Princípios e Indicação

A terapia vasoativa é uma das pedras angulares do manejo da HDA varicosa. Deve ser iniciada **imediatamente ao diagnóstico suspeito**, antes mesmo da realização da endoscopia. O objetivo é reduzir o fluxo e a pressão no território portal, controlando ou prevenindo o sangramento ativo.

Terlipressina

Análogo sintético da vasopressina com ação prolongada. Vasoconstritor esplâncnico potente. É o único fármaco vasoativo que demonstrou redução de mortalidade em ensaios clínicos randomizados.

Octreotídeo

Análogo da somatostatina. Reduz o fluxo portal por inibição do glucagon e de outros vasodilatadores esplâncnicos. Amplamente utilizado em países onde a terlipressina não está disponível ou é contraindicada.

Somatostatina

Fármaco original do qual o octreotídeo deriva. Ação similar, com meia-vida mais curta. Necessita de infusão contínua. Menos utilizada atualmente.

Mecanismo de Ação da Terlipressina

Farmacodinâmica

A terlipressina é um pró-fármaco que é convertido em **lisina-vasopressina** no organismo. Sua ação se dá principalmente por:

- **Vasoconstrição esplâncnica:** ligação aos receptores V1 nas células musculares lisas dos vasos esplâncnicos, promovendo contração vascular intensa e sustentada.
- **Redução do fluxo portal:** a diminuição do influxo esplâncnico reduz diretamente o volume e a pressão no sistema porta.
- **Redução da pressão nas varizes:** com menor pressão portal, a tensão parietal nas varizes diminui, facilitando a hemostasia espontânea e endoscópica.

Dados Clínicos e Posologia

Eficácia: Controla o sangramento ativo em 75–80% dos casos quando combinada ao tratamento endoscópico. É o único vasoativo com evidência de redução de mortalidade.

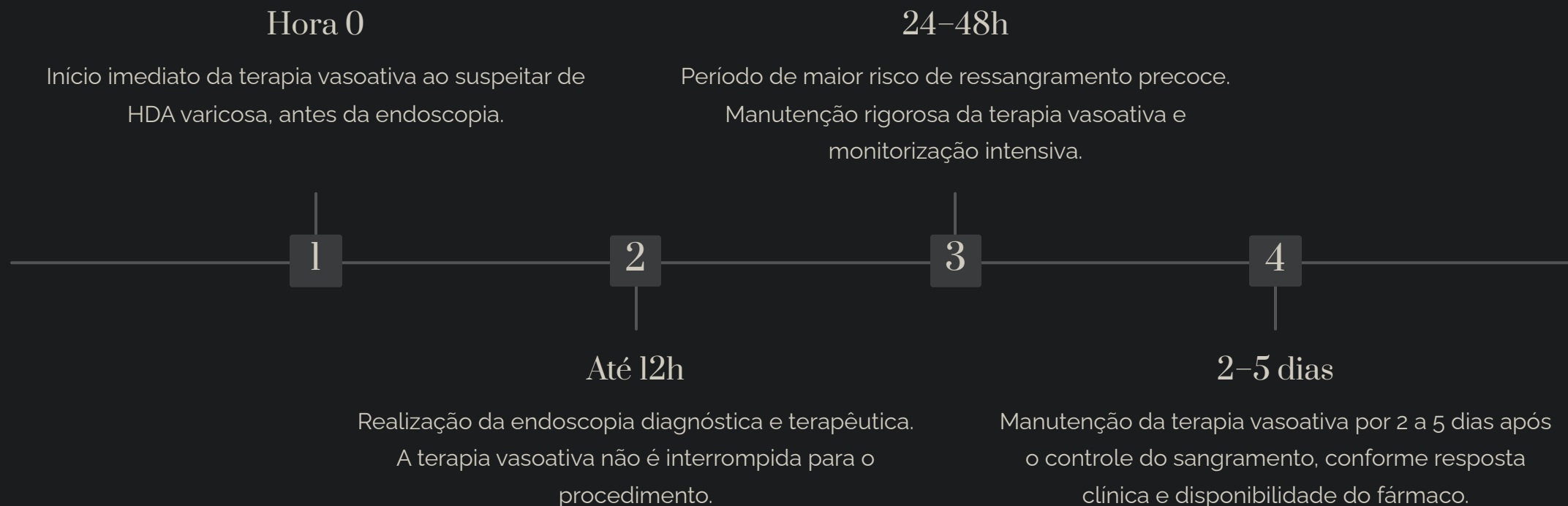
Dose inicial: 2 mg IV em bolus a cada 4–6 horas nas primeiras 48h; reduzir para 1 mg após controle do sangramento.

Contraindicações relativas: cardiopatia isquêmica, arritmias graves, doença vascular periférica avançada, gestação.

Efeitos adversos: hipertensão, bradicardia, isquemia periférica, hiponatremia.

Tempo de Uso da Terapia Vasoativa

A duração ideal da terapia vasoativa é baseada no período de maior risco de ressangramento precoce. As diretrizes do Baveno VII recomendam:



📌 A combinação de **terapia vasoativa + endoscopia + antibiótico** é a tríade fundamental do tratamento da HDA varicosa e demonstra eficácia superior a qualquer modalidade isolada.

Endoscopia na HDA Varicosa

Quando Realizar?

A endoscopia digestiva alta (EDA) deve ser realizada em até **12 horas** após a apresentação clínica do sangramento varicoso, em pacientes estáveis ou estabilizados. Em pacientes com instabilidade hemodinâmica refratária, a intubação orotraqueal profilática deve preceder o procedimento para proteção das vias aéreas.

A janela de 12 horas é baseada em evidências que mostram redução de mortalidade com abordagem precoce, sem benefício adicional comprovado em realizá-la em <6h (exceto instabilidade refratária).

Objetivos da Endoscopia

- **Diagnóstico:** confirmar a fonte do sangramento (varizes esofágicas vs. gástricas vs. outras causas)
- **Estadiamento:** avaliar o grau das varizes, presença de sinais vermelhos e extensão do sangramento
- **Tratamento:** hemostasia endoscópica imediata com a técnica mais adequada para o tipo de variz
- **Prognóstico:** identificar pacientes de alto risco para ressangramento e óbito

Tratamento Endoscópico das Varizes Esofágicas

Ligadura Elástica — Método de Escolha

A ligadura elástica (band ligation) é o tratamento endoscópico de primeira linha para varizes esofágicas. Consiste na aplicação de bandas elásticas na base das varizes, obliterando o vaso e induzindo necrose isquêmica local. A técnica tem taxa de controle do sangramento agudo em torno de 80–90% e é superior à escleroterapia em eficácia e segurança.

Escleroterapia — Alternativa Secundária

A escleroterapia endoscópica é uma alternativa quando a ligadura elástica não está disponível ou é tecnicamente inviável (hemorragia maciça com campo visual prejudicado). Consiste na injeção de agentes esclerosantes (etanolamina, polidocanol) dentro ou ao redor da variz. Apresenta mais complicações que a ligadura: úlceras esofágicas, estenose, mediastinite.



Tratamento das Varizes Gástricas — Cianoacrilato

Por que Varizes Gástricas são Diferentes?

As varizes gástricas, especialmente as do fundo gástrico (GOV2 e IGV1 pela classificação de Sarin), apresentam calibres maiores, fluxo mais elevado e paredes mais espessas. A ligadura elástica nesses locais tem alta taxa de falha e ressangramento precoce, além de risco de sangramento maciço durante o procedimento.

Cianoacrilato — Padrão para Varizes Gástricas

A injeção de **cianoacrilato (N-butil-2-cianoacrilato)** é o tratamento de escolha para varizes gástricas. O adesivo tecidual polimeriza em contato com o sangue, obliterando o vaso de forma rápida e eficaz. Taxas de controle do sangramento agudo superiores a 85–90%.

- Requer experiência do operador para evitar complicações (embolização pulmonar ou sistêmica)
- Alternativas emergentes: BRTO (balloon-occluded retrograde transvenous obliteration) para varizes gástricas refratárias

Falha Terapêutica — Definição e Manejo

A falha terapêutica na HDA varicosa é uma situação de alto risco que exige reconhecimento precoce e escalonamento imediato do tratamento. As diretrizes internacionais definem falha como:

Sangramento Persistente

Incapacidade de controlar o sangramento ativo durante ou após a endoscopia, com necessidade de transfusão de mais de 2 unidades de concentrado de hemácias em 24 horas para manter Hb estável.

Ressangramento Precoce

Novo episódio de sangramento nas primeiras 120 horas (5 dias) após o controle inicial, caracterizado por hematêmese, queda de Hb >3 g/dL ou instabilidade hemodinâmica.

Escalonamento Obrigatório

Falha endoscópica ou recidiva precoce exigem avaliação imediata para TIPS ou, como ponte temporária, uso do balão de Sengstaken-Blakemore até disponibilidade do procedimento definitivo.

Balão de Sengstaken-Blakemore

Indicação e Uso Clínico

O balão de Sengstaken-Blakemore (BSB) é um dispositivo de tamponamento esofagogástrico utilizado exclusivamente como medida de **resgate temporário** em casos de sangramento varicoso maciço refratário ao tratamento farmacológico e endoscópico. Seu objetivo é estabilizar o paciente até que um tratamento definitivo (TIPS ou segunda endoscopia) possa ser realizado.

O dispositivo possui três lumens: um para balão gástrico, um para balão esofágico e um para drenagem gástrica. Após posicionamento por fluoroscopia, os balões são insuflados sequencialmente para comprimir as varizes.

Complicações — Atenção Máxima

O uso do BSB está associado a complicações potencialmente fatais, especialmente quando utilizado sem intubação orotraqueal prévia ou por operadores inexperientes:

- **Aspiração pulmonar:** risco elevado de pneumonia aspirativa e SDRA; intubação é obrigatória.
- **Necrose esofágica:** insuflação excessiva ou prolongada do balão esofágico por mais de 24h.
- **Perfuração esofágica:** complicação catastrófica, especialmente com malposicionamento do dispositivo.
- **Deslocamento proximal:** risco de obstrução de vias aéreas se o balão migrar para a faringe.

❏ O BSB nunca deve ser mantido por mais de 24 horas. Requer UTI e monitorização contínua.

TIPS — Shunt Portossistêmico Intrahepático Transjugular

O TIPS é um procedimento de radiologia intervencionista que cria uma comunicação artificial entre a veia porta e a veia hepática por via intrahepática, utilizando uma prótese metálica expansível. É o principal procedimento de resgate na HDA varicosa refratária.

Indicações

- Falha do tratamento endoscópico (sangramento persistente ou ressangramento precoce)
- TIPS precoce (dentro de 72h) em pacientes Child B com sangramento ativo ou Child C até 13 pontos — evidência nível A
- Pacientes de alto risco com GPVH >20 mmHg na admissão

Mecanismo

O TIPS decomprime o sistema portal ao desviar o fluxo sanguíneo diretamente para a circulação sistêmica, reduzindo o GPVH em 50–60%. O resultado é redução imediata da pressão nas varizes e cessação do sangramento.

Complicações

- **Encefalopatia hepática:** ocorre em 20–30% dos casos por desvio de amônia e outros metabólitos
- **Insuficiência hepática:** pelo desvio do sangue portal rico em fatores hepatotróficos
- **Disfunção da prótese:** estenose ou trombose, especialmente com stents não recobertos

Profilaxia Secundária da HDA Varicosa

Após o controle do episódio agudo, a prevenção do ressangramento é obrigatória. Sem profilaxia secundária, a taxa de ressangramento em 1 ano supera 60% e a mortalidade acumulada é alta. A combinação de tratamento farmacológico e endoscópico é o padrão atual.

Betabloqueadores Não Cardiosseletivos

Propranolol ou carvedilol reduzem o débito cardíaco e promovem vasoconstrição esplâncnica, diminuindo o fluxo portal. O carvedilol tem efeito anti- α_1 adicional, sendo mais potente na redução do GPVH. Dose ajustada para FC 55–60 bpm ou máxima tolerada.



Ligadura Elástica Seriada

Sessões de ligadura a cada 2–4 semanas até obliteração completa das varizes. Combinada com betabloqueadores, reduz o ressangramento de forma sinérgica. Após erradicação, vigilância endoscópica a cada 6–12 meses.

📌 **Baveno VII:** A combinação de carvedilol + ligadura elástica é a estratégia preferencial de profilaxia secundária. TIPS deve ser considerado em pacientes com falha combinada ou alto risco de ressangramento precoce.

Profilaxia Primária das Varizes Esofágicas

Quem se Beneficia?

A profilaxia primária é indicada em pacientes cirróticos com **varizes de médio e grande calibre** ou com varizes de qualquer tamanho associadas a sinais vermelhos (red signs) ou Child B/C. Pacientes com varizes pequenas sem sinais de risco têm indicação controversa e devem ser monitorados.

Estratégias Disponíveis

- **Betabloqueadores não cardiosseletivos (BBNS):** propranolol ou carvedilol são a primeira linha. Reduzem o risco de primeiro sangramento em cerca de 50%. Preferência ao carvedilol por maior redução do GPVH.
- **Ligadura elástica profilática:** indicada quando há contraindicação ou intolerância aos BBNS. Eficácia similar aos fármacos na prevenção do primeiro sangramento.
- **Combinação:** não demonstrou superioridade sobre monoterapia na profilaxia primária; reservada para casos selecionados.

CAPÍTULO 2

Hemorragia Digestiva Baixa (HDB)

A HDB, definida como sangramento originado distalmente ao ângulo de Treitz (duodeno-jejunal), com origem mais comum no cólon e reto, representa um grupo heterogêneo de condições com espectro variável de gravidade. Compreender suas causas e a abordagem sistemática é essencial para o especialista.



Principais Causas de HDB

A etiologia da HDB varia conforme a faixa etária, comorbidades e contexto clínico. O conhecimento epidemiológico das causas orienta a suspeita diagnóstica ainda na avaliação inicial.



Doença Diverticular

Principal causa de HDB em adultos acima de 50 anos. Sangramentos geralmente volumosos, indolores e autolimitados (70–80% cessam espontaneamente). Decorre de erosão de vasa recta pela cúpula diverticular.



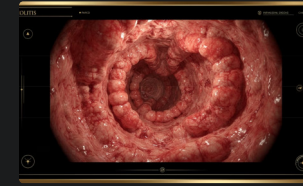
Angiodisplasia

Ectasias vasculares da mucosa colônica, mais comuns no cólon direito. Associadas ao envelhecimento e a doenças como doença valvar aórtica e doença renal crônica. Causa frequente de sangramento recorrente crônico.



Neoplasias Colorretais

Podem causar sangramento crônico oculto ou, menos frequentemente, hematoquezia aguda. Devem ser sempre excluídas em qualquer episódio de HDB, especialmente em pacientes >50 anos.



Colites

Incluem colite infecciosa, doença inflamatória intestinal (DII) e colite isquêmica. Geralmente acompanhadas de dor abdominal, diarreia e febre. A colite isquêmica é mais comum em idosos com aterosclerose.

Apresentação Clínica da HDB

Hematoquezia

A apresentação mais característica da HDB é a **hematoquezia** — eliminação de sangue vermelho vivo ou marrom-escuro pela ampola retal, geralmente misturado com fezes ou isolado. O caráter do sangramento oferece pistas etiológicas importantes:

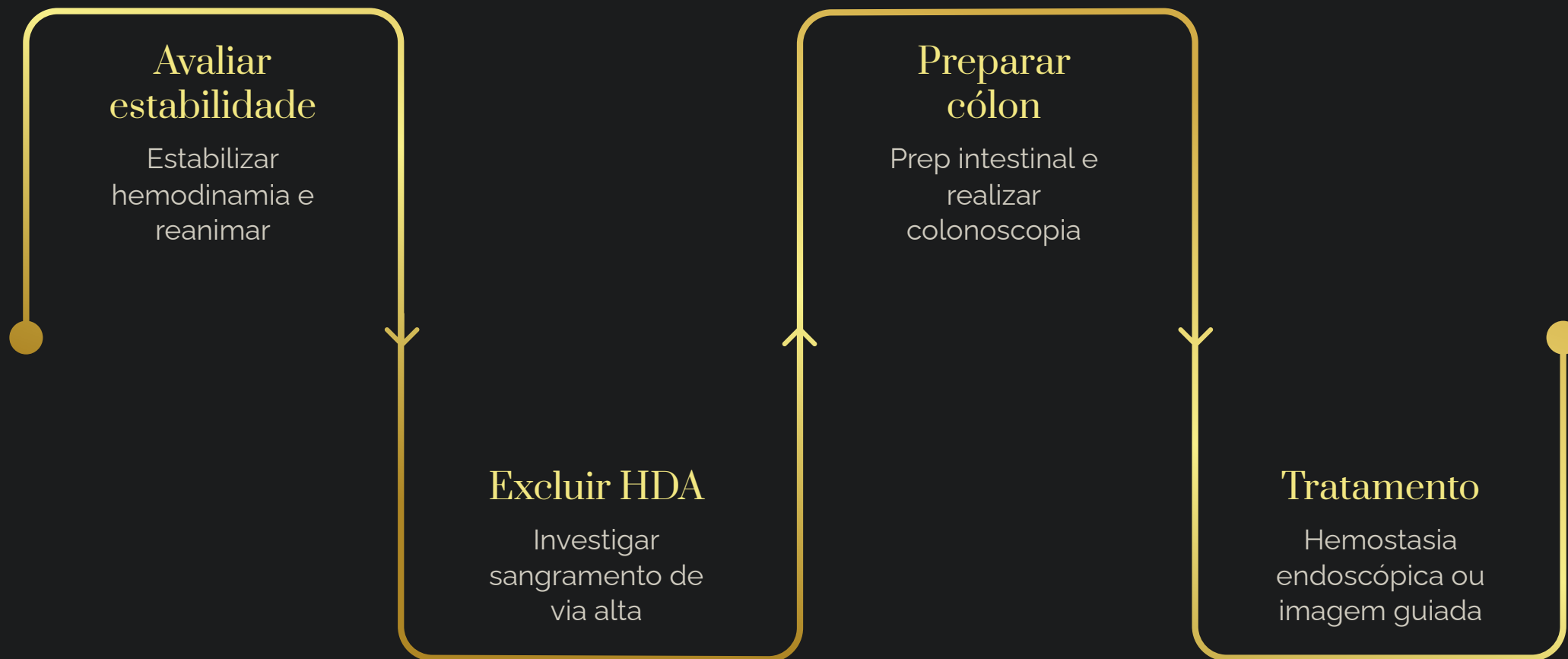
- **Sangue vivo cobrindo as fezes:** sugere origem retal ou sigmoide (hemorroidas, fissura, proctite)
- **Sangue misturado às fezes:** origem mais proximal, como cólon esquerdo ou transversal
- **Sangramento indolor e volumoso:** altamente sugestivo de doença diverticular
- **Sangramento com muco e dor:** sugestivo de colite (infecciosa, inflamatória ou isquêmica)

Atenção: Excluir HDA!

Importante lembrar que **10–15% dos pacientes com hematoquezia têm HDA como origem**. Em sangramentos volumosos com instabilidade hemodinâmica, sempre excluir fonte alta antes de proceder à colonoscopia. A passagem de sonda nasogástrica com aspirado hemático sugere origem alta; aspirado claro não exclui HDA (pode não haver refluxo duodenal).

A presença de sinais de cirrose, uso de AINEs ou anticoagulantes, úlcera prévia e melena associada são pistas para HDA.

Abordagem Inicial da HDB



A abordagem inicial da HDB segue princípios semelhantes aos da HDA: estabilização hemodinâmica em primeiro lugar, seguida de investigação diagnóstica direcionada. A exclusão de HDA é etapa obrigatória antes da colonoscopia.

Colonoscopia na HDB — Exame Principal

Por que a Colonoscopia é Central?

A colonoscopia é o exame de escolha para HDB pois permite simultaneamente o **diagnóstico da etiologia** e o **tratamento endoscópico** do sangramento. Diferentemente de outros métodos de imagem, a colonoscopia pode identificar e tratar lesões como angiodisplasias, divertículos sangrantes e pólipos com um único procedimento.

Tempo Ideal e Preparo

- **Colonoscopia urgente:** idealmente dentro de **24 horas** em pacientes estáveis ou estabilizados. Estudos mostram melhora nos desfechos com abordagem precoce.
- **Preparo intestinal:** lavagem intestinal com polietilenoglicol (4–6L) em 3–4 horas é obrigatória para melhorar a visualização. Colonoscopia sem preparo tem rendimento diagnóstico muito inferior.
- **Exceção:** pacientes com sangramento maciço e instabilidade podem necessitar de angiografia diagnóstica e terapêutica antes da colonoscopia.

Tratamento Endoscópico na HDB

Quando a colonoscopia identifica a fonte do sangramento, diversas técnicas de hemostasia endoscópica estão disponíveis, escolhidas conforme a etiologia e o tipo de lesão:



Clips Hemostáticos

Indicados para vasos visíveis, pseudoaneurismas de vasa recta em divertículos e sangramento pós-polipectomia. Aplicação direta sobre o vaso sangrante. Alta eficácia e baixo risco de perfuração.



Coagulação Bipolar / Plasma de Argônio

Utilizados para angiodisplasias e lesões vasculares planas. O plasma de argônio (APC) é especialmente eficaz em angiodisplasias difusas do cólon direito, com menor risco de perfuração por não haver contato direto.



Injeção de Epinefrina

Efeito hemostático temporário por vasoconstricção e tamponamento local. Deve ser sempre combinada com outro método (clips ou coagulação), pois isoladamente tem alta taxa de ressangramento.

Angiodisplasia Colônica

Características da Lesão

A angiodisplasia é uma **ectasia vascular adquirida da mucosa e submucosa** do trato gastrointestinal. Caracteriza-se por:

- Lesões avermelhadas, planas ou levemente elevadas, em geral ≤ 10 mm
- Localização preferencial no **cólon direito** (ceco e cólon ascendente)
- Associação com envelhecimento, doença valvar aórtica (síndrome de Heyde), DRC e von Willebrand
- Causa frequente de sangramento recorrente e anemia ferropriva inexplicada

Tratamento com Plasma de Argônio (APC)

O **plasma de argônio (APC)** é o método endoscópico preferencial para angiodisplasias. A corrente de alta frequência é conduzida por gás argônio ionizado até a lesão, coagulando sem contato direto.

Vantagens:

- Penetração superficial controlada (1–3 mm) — ideal para lesões de mucosa fina
- Pode tratar múltiplas lesões em uma sessão
- Menor risco de perfuração vs. eletrocoagulação de contato
- Taxa de sucesso 80–90% em uma ou duas sessões

Doença Diverticular — Principal Causa de HDB

A doença diverticular é a causa mais comum de HDB aguda volumosa em adultos acima de 50 anos nos países ocidentais, respondendo por 30–50% dos casos em alguns séries.

Mecanismo de Sangramento

Os divertículos são pseudodivertículos (hérnias da mucosa e submucosa através da muscular) que se formam nos pontos de menor resistência da parede colônica, onde os vasa recta penetram. O sangramento ocorre por erosão assimétrica e ruptura desses vasos na cúpula do divertículo.

Características Clínicas

O sangramento diverticular é tipicamente **súbito, indolor e volumoso**, com eliminação de sangue vermelho vivo ou marrom. Em 70–80% dos casos, cessa espontaneamente. O ressangramento, porém, ocorre em 25–40% dos pacientes não tratados.

Tratamento

Hemostasia endoscópica com clips ou coagulação bipolar quando o divertículo sangrante é identificado. Em casos refratários: angioembolização ou ressecção cirúrgica segmentar. A colectomia é reservada para sangramento refratário ou recorrente grave.

Neoplasias e Colites como Causas de HDB

Neoplasias Colorretais

Os tumores colorretais podem causar dois padrões distintos de sangramento:

- **Sangramento crônico oculto:** mais comum, levando a anemia ferropriva progressiva. Detectado por pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- **Hematoquezia aguda:** menos frequente, geralmente em tumores avançados ou ulcerados. Pode ser volumosa em tumores vasculares.

Todo episódio de HDB em pacientes acima de 50 anos ou com histórico familiar de câncer colorretal deve incluir colonoscopia completa para rastreamento, mesmo que outra causa seja identificada inicialmente.

Colites — Três Tipos Principais

- **Colite Infecçiosa:** diarreia sanguinolenta + febre + leucocitose. Agentes: Salmonella, Shigella, Campylobacter, STEC. Coprocultura e endoscopia confirmam.
- **Colite Inflamatória (DII):** retocolite ulcerativa e Crohn colônico. Sangramento típico com muco, tenesmo e episódios recorrentes. Diagnóstico histológico.
- **Colite Isquêmica:** comum em idosos com aterosclerose. Dor abdominal súbita no flanco esquerdo + sangramento. Imagem em "impressões digitais" na TC. Maioria autolimitada.

CAPÍTULO 3

Hemorragia Digestiva Média (HDM)

A hemorragia digestiva média, também chamada de sangramento obscuro, é definida como aquela originada entre o ângulo de Treitz e a válvula ileocecal — ou seja, no intestino delgado. Representa um desafio diagnóstico particular por ser inacessível à endoscopia convencional.



Causas da HDM — Intestino Delgado

O intestino delgado, apesar de representar 75% do comprimento do trato digestivo, é responsável por apenas 5–10% dos casos de hemorragia digestiva. As causas variam conforme a faixa etária e as comorbidades:

Angiodisplasia

Principal causa em pacientes acima de 60 anos. Lesões vasculares planas, difusas, mais comuns no jejuno proximal. Frequentemente múltiplas. Associadas à DRC e doença cardíaca valvar.

Tumores de Intestino Delgado

GIST, linfoma, adenocarcinoma e tumores carcinoides. Podem causar sangramento agudo ou crônico. A cápsula endoscópica tem alta sensibilidade para detectar lesões subepiteliais e ulceradas.

Doença de Crohn

Úlceras profundas no íleo terminal ou jejuno podem causar sangramento significativo. Geralmente associado a outras manifestações (dor, diarreia, emagrecimento). A enteroscopia permite biópsias.

Outras Causas

Divertículo de Meckel (principalmente em jovens), úlceras por AINEs, lesão de Dieulafoy de intestino delgado e sangramento pós-cirúrgico são causas menos frequentes mas importantes no diagnóstico diferencial.

Diagnóstico da HDM — Métodos Disponíveis

Cápsula Endoscópica

A cápsula endoscópica é o exame de primeira linha para investigação do intestino delgado em casos de sangramento obscuro após EDA e colonoscopia normais. Trata-se de uma cápsula ingerida pelo paciente que captura imagens em alta resolução ao longo de todo o intestino delgado.

Vantagens: não invasiva, alta sensibilidade (60–80% para sangramento obscuro), boa tolerabilidade, diagnóstico em ambatório.

Limitações: não permite intervenção terapêutica, risco de retenção em estenoses (TC prévia recomendada), menor rendimento em sangramento inativo.

Melhor indicação: sangramento obscuro ativo ou recente (nas primeiras 48h — rendimento máximo).

Enteroscopia

A enteroscopia (por balão único, duplo ou espiral) permite a exploração profunda do intestino delgado com possibilidade de **diagnóstico E tratamento simultâneos**. Técnica de segunda linha após cápsula ou em pacientes com achados que requerem biópsia ou hemostasia.

- **Via anterógrada:** acesso pelo duodeno/jejuno proximal
- **Via retrógrada:** acesso pelo íleo terminal
- Permite coagulação com APC, clips, injeção e biópsias direcionadas
- Rendimento diagnóstico superior quando guiada pelos achados da cápsula endoscópica

Cápsula Endoscópica — Detalhes Técnicos e Indicações

A cápsula endoscópica é um dos maiores avanços da gastroenterologia para investigação do intestino delgado. O dispositivo mede aproximadamente 11 x 26 mm e captura 2–6 imagens por segundo ao longo de 8–12 horas de operação.

Alta Sensibilidade para Sangramento Obscuro

Metanálises demonstram sensibilidade de **60–80%** para detecção de lesões em sangramento obscuro, superior à enteroscopia isolada e à angiografia (quando o sangramento não está ativo). O rendimento diagnóstico cai significativamente quando realizada mais de 72 horas após cessação do sangramento.

Quando Solicitar

- Sangramento obscuro após EDA e colonoscopia normais
- Anemia ferropriva inexplicada com endoscopias negativas
- Suspeita de Crohn de intestino delgado (com exclusão de estenose prévia)
- Sangramento ativo com melena ou hematoquezia sem fonte identificada

CAPÍTULO 4

Casos Clínicos — Aplicação Prática

Os casos clínicos a seguir traduzem o conhecimento teórico em cenários reais de tomada de decisão. Cada caso exige integração de raciocínio fisiopatológico, estratificação de risco e definição da conduta mais adequada baseada em evidências.



Caso 1 — Hematêmese em Paciente Cirrótico

Apresentação

Homem, 52 anos, cirrótico (Child B, 8 pontos), com icterícia leve e ascite de moderado volume. Deu entrada na UPA com hematêmese volumosa de sangue vivo, hipotensão (PA 90x60 mmHg), FC 112 bpm, Hb 8,2 g/dL. Já em uso de propranolol 40 mg/dia para profilaxia primária.

Conduta Sistematizada

1. **Estabilização imediata:** dois acessos calibrosos, monitorização contínua, avaliar necessidade de IOT (Glasgow 15 — não indicada de imediato)
2. **Reposição volêmica cautelosa:** SF 0,9% em volume controlado; meta: PAS >90 mmHg sem sobrecarga
3. **Terapia vasoativa:** terlipressina 2 mg IV em bolus, imediatamente
4. **Antibioticoprofilaxia:** ceftriaxona 1 g IV já na admissão
5. **Transfusão restritiva:** CH se Hb <7 g/dL ou instabilidade
6. **EDA urgente:** dentro de 12 horas com ligadura elástica das varizes

Caso 2 — Melena com Instabilidade Hemodinâmica

Apresentação

Mulher, 68 anos, com histórico de uso de AAS 100 mg/dia e ibuprofeno esporádico para artrite. Admitida com melena há 2 dias, lipotimia ao levantar, PA 85x55 mmHg, FC 125 bpm, Hb 6,8 g/dL, ureia 98 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL. Sem sinais de cirrose. Aspirado nasogástrico: material com aspecto de borra de café.

Conduta

1. **Ressuscitação volêmica agressiva:** SF 0,9% em bolus 500 mL; sem restrição inicial em não cirrótico
2. **Transfusão:** Hb 6,8 com instabilidade — indicação absoluta de CH
3. **IBP:** pantoprazol 80 mg IV em bolus + infusão de 8 mg/h
4. **EDA urgente:** dentro de 12h (instabilidade hemodinâmica = critério de urgência)
5. **Suspender AINEs** definitivamente; manter AAS apenas se risco cardiovascular alto após discussão

Achado provável: úlcera péptica gástrica ou duodenal — Forrest Ia/Ib em cenário de instabilidade.

Caso 3 — Hematoquezia Maciça

Apresentação

Homem, 74 anos, hipertenso, dislipidêmico, sem cirrose. Admitido com hematoquezia volumosa (4 episódios em 3 horas), PA 100x70 mmHg (com melhora após volume), FC 100 bpm, Hb 9,4 g/dL, sem dor abdominal. Colonoscopia há 2 anos: diverticulose difusa, sem pólipos.

Conduta

1. **Excluir HDA:** aspirado nasogástrico claro (não exclui 100%) → EDA rápida ou escore de risco baixo para HDA → prosseguir para colonoscopia
2. **Estabilização:** SF + CH conforme necessidade; meta Hb >7 g/dL
3. **Preparo intestinal:** polietilenoglicol 4L em 4 horas
4. **Colonoscopia urgente:** em até 24h após preparo adequado
5. **Se divertículo sangrante identificado:** hemostasia com clip ou coagulação bipolar
6. **Se falha endoscópica:** angioembolização por radiologia intervencionista

Caso 4 — Sangramento Recorrente sem Diagnóstico

Apresentação

Homem, 65 anos, com três internações por anemia ferropriva sintomática nos últimos 18 meses, necessitando de transfusões repetidas. EDA prévia: gastrite leve, sem úlcera, sem varizes. Colonoscopia: diverticulose sem sinais de sangramento recente. Hb atual: 7,1 g/dL. Fezes positivas para sangue oculto.

Conduta — Sangramento Obscuro

1. **Repetir EDA e colonoscopia** com atenção redobrada a lesões subepiteliais ou planas (Dieulafoy, angiodisplasia)
2. **Cápsula endoscópica:** exame de primeira linha para intestino delgado — idealmente realizada em momento próximo ao sangramento ativo
3. **Se cápsula positiva:** enteroscopia dirigida (anterógrada ou retrógrada conforme localização) para diagnóstico definitivo e tratamento
4. **Se cápsula negativa com sangramento ativo:** angiografia com TC ou cintilografia com hemácias marcadas

Diagnóstico provável: angiodisplasia de intestino delgado — causa mais frequente de HDM em idosos.

Caso 5 — Úlcera com Estigma de Alto Risco (Forrest IIa)

Apresentação

Homem, 58 anos, com dor epigástrica há 3 semanas e melena. PA 120x80 mmHg, FC 88 bpm, Hb 9,8 g/dL. EDA revela úlcera duodenal de 12 mm com vaso visível não sangrante (Forrest IIa) e coágulo aderido ao fundo.

Conduta — Forrest IIa

O Forrest IIa (vaso visível) tem risco de ressangramento de **40–50%** sem tratamento endoscópico, justificando hemostasia imediata:

1. **Hemostasia endoscópica:** combinação preferencial — injeção de epinefrina + clip hemostático ou termocoagulação
2. **Remoção do coágulo:** irrigação vigorosa para expor o vaso; hemostasia definitiva do leito ulceroso
3. **IBP em dose plena:** pantoprazol 80 mg IV bolus + 8 mg/h por 72h; depois 40 mg VO 12/12h por 8 semanas
4. **Teste para H. pylori:** urease rápida ou histologia; se positivo → erradicação obrigatória
5. **Suspender AINEs;** avaliar proteção gástrica se AAS necessário

Raciocínio Clínico Avançado — As Três Perguntas Fundamentais

Diante de qualquer paciente com hemorragia digestiva, o especialista deve ter na mente três perguntas-guia que estruturam toda a tomada de decisão clínica. Respondê-las em ordem é o diferencial entre o manejo eficiente e a conduta reativa.

1 De onde está sangrando?

Diferenciar HDA, HDB e HDM com base na apresentação clínica (hematêmese, melena, hematoquezia), exames laboratoriais (ureia/creatinina, Hb, coagulograma) e dados epidemiológicos (cirrose, uso de AINEs, idade, história prévia). A localização define o exame diagnóstico e o especialista que deve ser acionado.

2 Qual é a gravidade?

Estratificar o risco com escores validados (Glasgow-Blatchford, Rockall, AIMS65 para HDA; Child-Pugh e GPVH para varicosa; instabilidade hemodinâmica para qualquer tipo). A gravidade define a urgência do exame, a necessidade de UTI e o nível de intervenção requerido.

3 Qual é a intervenção imediata?

Simultaneamente à estabilização: vasoativo ou IBP? Antibiótico? Quando chamar endoscopia? É necessário transferência para centro terciário com TIPS? A resposta deve ser imediata, baseada em protocolo e antecipada antes do deterioramento clínico.

Erros Graves na Prática — O Que Nunca Fazer

O conhecimento dos erros mais comuns e seus impactos na morbimortalidade é tão importante quanto dominar as condutas corretas. Evitar esses erros diferencia o especialista do clínico geral.

Atrasar a Endoscopia

Aguardar estabilização clínica "completa" antes de solicitar endoscopia é um erro frequente. A EDA urgente (≤ 12 h na HDA varicosa e ≤ 24 h na HDA não varicosa instável) é ela mesma parte do tratamento, não apenas diagnóstico. Cada hora de atraso eleva a mortalidade, especialmente em Forrest I e HDA varicosa ativa.

Não Tratar Varizes Adequadamente

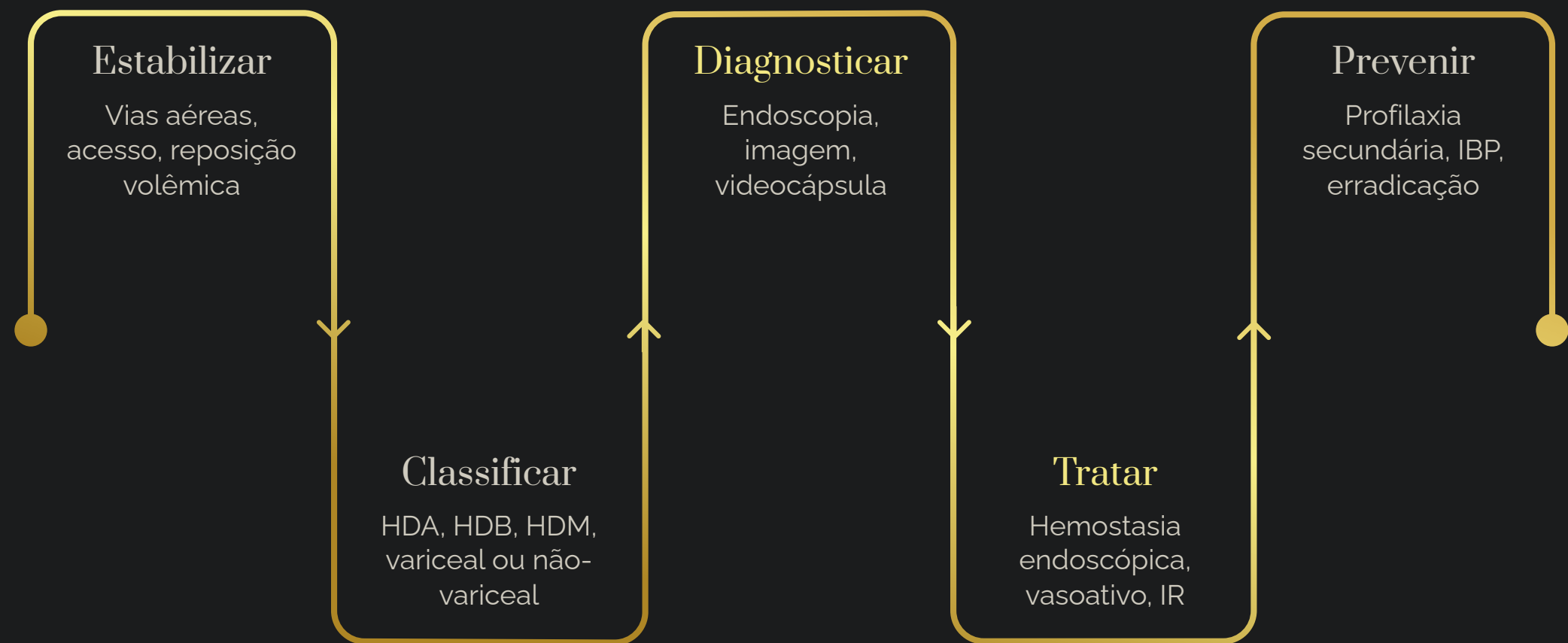
Tratar HDA varicosa sem iniciar vasoativo, sem antibioticoprofilaxia ou com técnica endoscópica incorreta (escleroterapia em vez de ligadura, cianoacrilato em varizes esofágicas) é erro grave. A ligadura deve ser o método preferencial para varizes esofágicas; o cianoacrilato, para gástricas.

Transfusão Excessiva (Liberal)

Em cirróticos com HDA varicosa, transfundir para Hb $>9-10$ g/dL aumenta a pressão portal, favorece ressangramento e piora a mortalidade. A meta restritiva (Hb 7–9 g/dL) tem evidência de nível A. Confundir "instabilidade" com "necessidade de transfundir agressivamente" é um erro que custa vidas.

Fluxo Mental do Especialista

O especialista em hemorragia digestiva não age de forma linear e sequencial, mas de forma **paralela e antecipatória**. O fluxo mental integrado é o que distingue a abordagem de excelência:



Este fluxo deve ser executado de forma rápida e estruturada, com cada etapa sendo realizada em paralelo sempre que possível. A antecipação das próximas etapas enquanto a anterior ainda está em andamento é o que permite reduzir o tempo de intervenção e melhorar os desfechos.

Integração Completa — HDA, HDB e HDM como Espectro Único

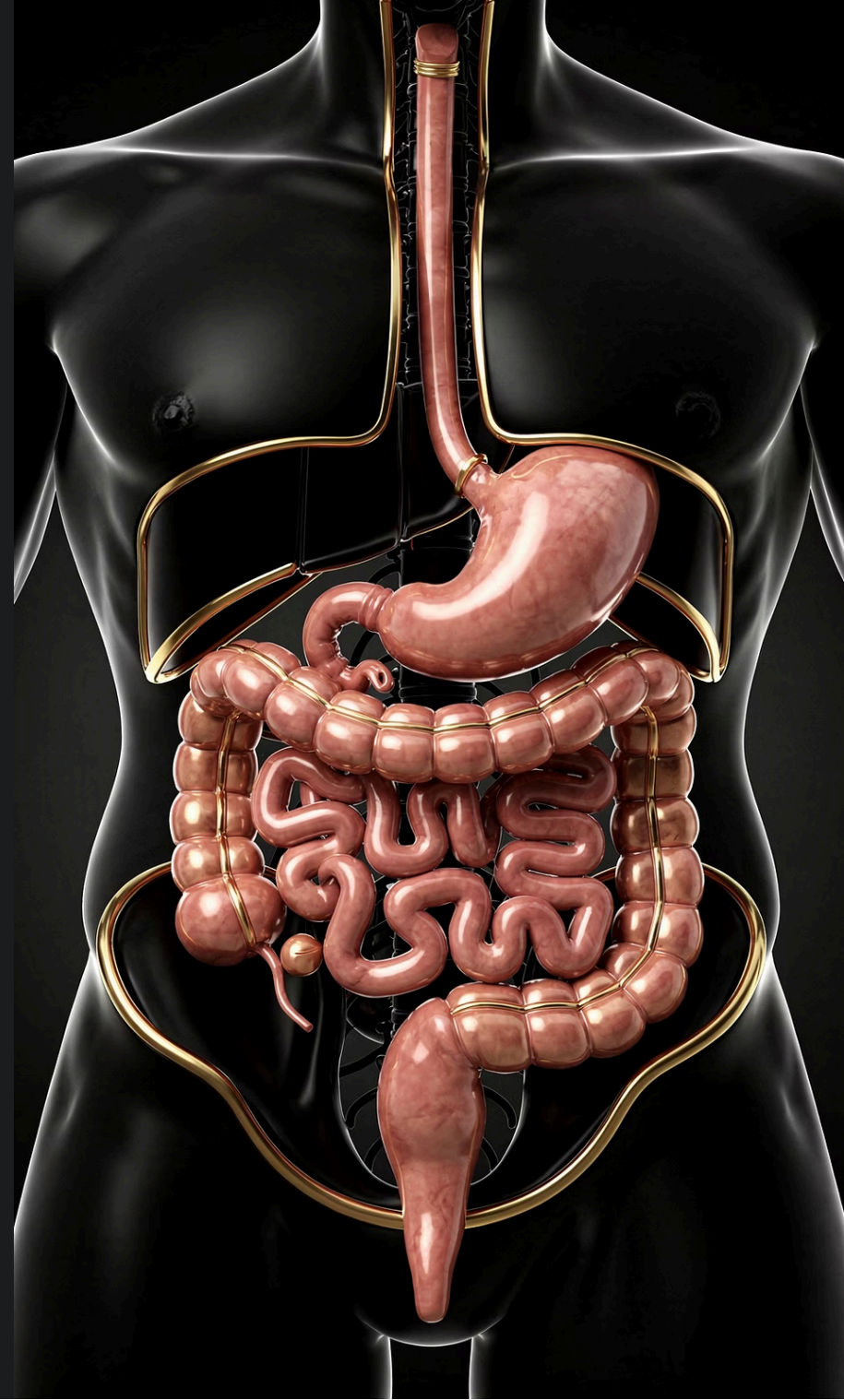
Um dos erros conceituais mais comuns é tratar HDA, HDB e HDM como entidades completamente separadas com lógicas distintas. Na prática, elas fazem parte de um **espectro clínico contínuo** que compartilha princípios fundamentais.

Princípios Compartilhados

- Estabilização hemodinâmica sempre em primeiro lugar
- Identificação do tipo e localização do sangramento
- Estratificação de risco baseada em escores validados
- Endoscopia como eixo diagnóstico e terapêutico central

O que Diferencia Cada Tipo

- HDA varicosa: fisiopatologia da hipertensão portal, vasoativo obrigatório, antibiótico universal
- HDA não varicosa: IBP em dose plena, hemostasia endoscópica, H. pylori
- HDB: preparo intestinal, colonoscopia, técnicas de hemostasia locais
- HDM: cápsula endoscópica de primeira linha, enteroscopia terapêutica



Tomada de Decisão Real — Evidência, Experiência e Estrutura

A tomada de decisão na prática clínica real é moldada por três pilares que o especialista deve equilibrar permanentemente:



Evidência Científica

As diretrizes internacionais (Baveno VII, ACG, ESGE) fornecem recomendações baseadas em graus de evidência. Conhecer o nível de recomendação de cada conduta permite ao especialista tomar decisões fundamentadas e justificá-las perante a equipe e familiares. Evidência nível A é inegociável; nível C exige julgamento clínico adicional.



Experiência Clínica

A habilidade endoscópica, a capacidade de reconhecer padrões clínicos atípicos e a intuição diagnóstica construída ao longo de anos são insubstituíveis. A experiência filtra e contextualiza a evidência para o paciente individual, considerando nuances que nenhuma diretriz consegue abranger completamente.



Estrutura Disponível

A decisão ideal no papel pode ser inviável sem a infraestrutura adequada. O especialista deve conhecer os limites do seu serviço (disponibilidade de TIPS, cápsula endoscópica, radiologia intervencionista 24h) e saber quando e como transferir o paciente para um centro de maior complexidade.

Impacto do Diagnóstico Precoce

A agilidade diagnóstica e terapêutica tem impacto direto e mensurável nos desfechos da hemorragia digestiva. Dados da literatura consolidam o benefício inequívoco da abordagem precoce:

50%

Redução da Mortalidade

Com EDA nas primeiras 12–24h vs. abordagem tardia em HDA de alto risco. Diferença de 5 pontos percentuais absolutos (NNT ~20).

3x

Maior Chance de Hemostasia

Endoscopia urgente tem três vezes mais chance de encontrar lesão sangrante ativa com possibilidade de hemostasia definitiva vs. endoscopia eletiva.

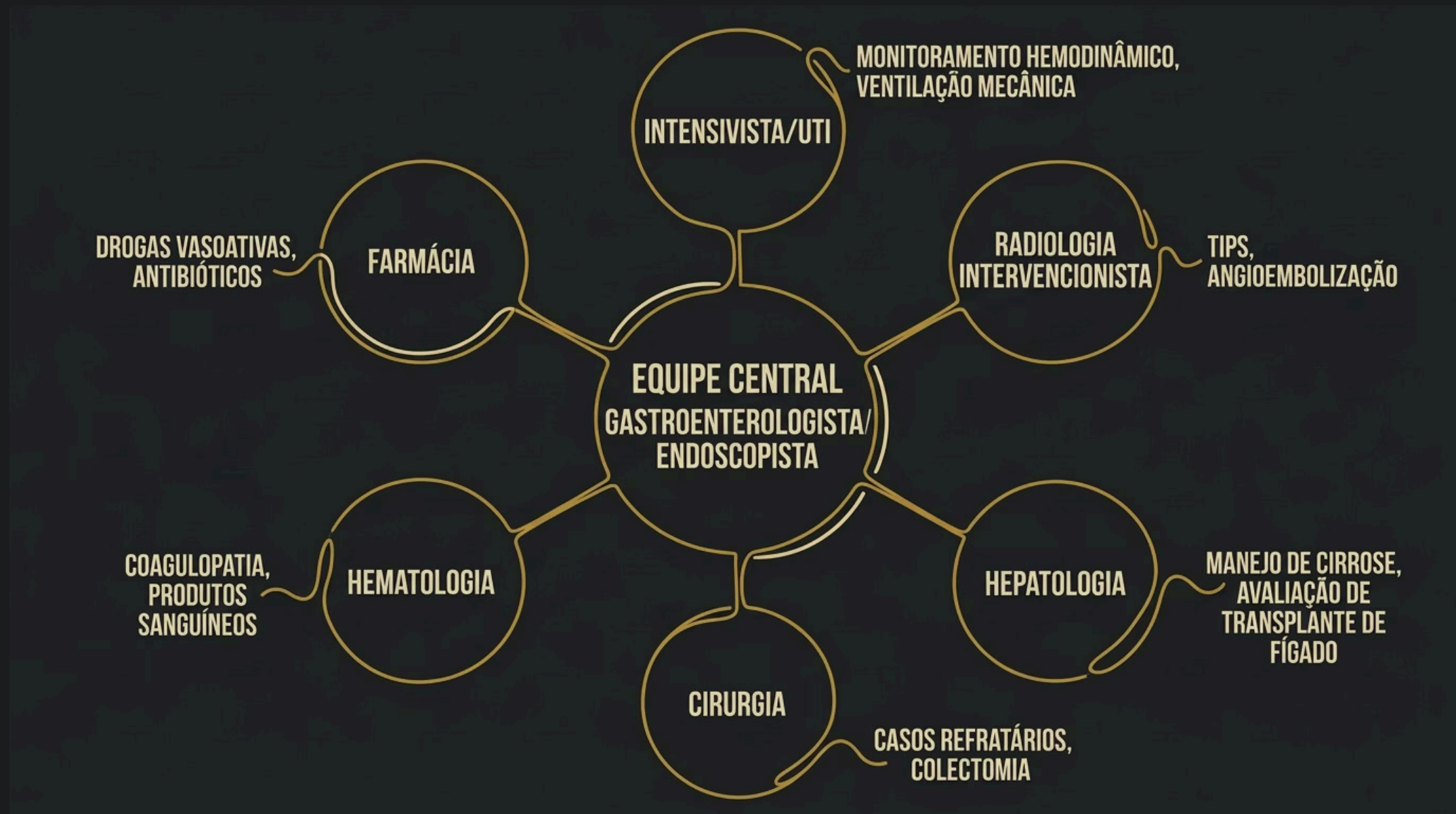
30%

Redução do Tempo de Internação

Abordagem estruturada e precoce reduz o tempo médio de internação em até 30%, com impacto significativo nos custos hospitalares e na qualidade de vida do paciente.

Hemorragia Digestiva como Emergência Multidisciplinar

A hemorragia digestiva grave raramente é gerenciada por um único especialista. A excelência no manejo depende da integração de múltiplas equipes trabalhando de forma coordenada e protocolizada:



O papel do gastroenterologista especialista é ser o coordenador central dessa rede multidisciplinar, acionando cada equipe no momento certo, garantindo a continuidade do cuidado e tomando as decisões mais complexas de escalonamento terapêutico.

Profilaxia: Fechando o Ciclo do Cuidado

O manejo da hemorragia digestiva não termina com a hemostasia aguda. A prevenção da recorrência é parte indissociável do tratamento e deve ser planejada ainda durante a internação. A ausência de profilaxia representa uma falha assistencial grave.

1

Episódio Agudo Controlado

Hemostasia endoscópica, terapia vasoativa, antibiótico, transfusão restritiva, IBP em dose plena.

2

Estratificação Pós-Aguda

Classificar Child-Pugh, MELD, Forrest, H. pylori, uso de AINEs, risco cardiovascular. Definir intensidade da profilaxia.

3

Profilaxia Secundária

Betabloqueadores + ligadura seriada (varicosa); IBP + erradicação de H. pylori (úlceras); suspensão de AINEs; anticoagulação cautelosa se indicada.

4

Seguimento Ambulatorial

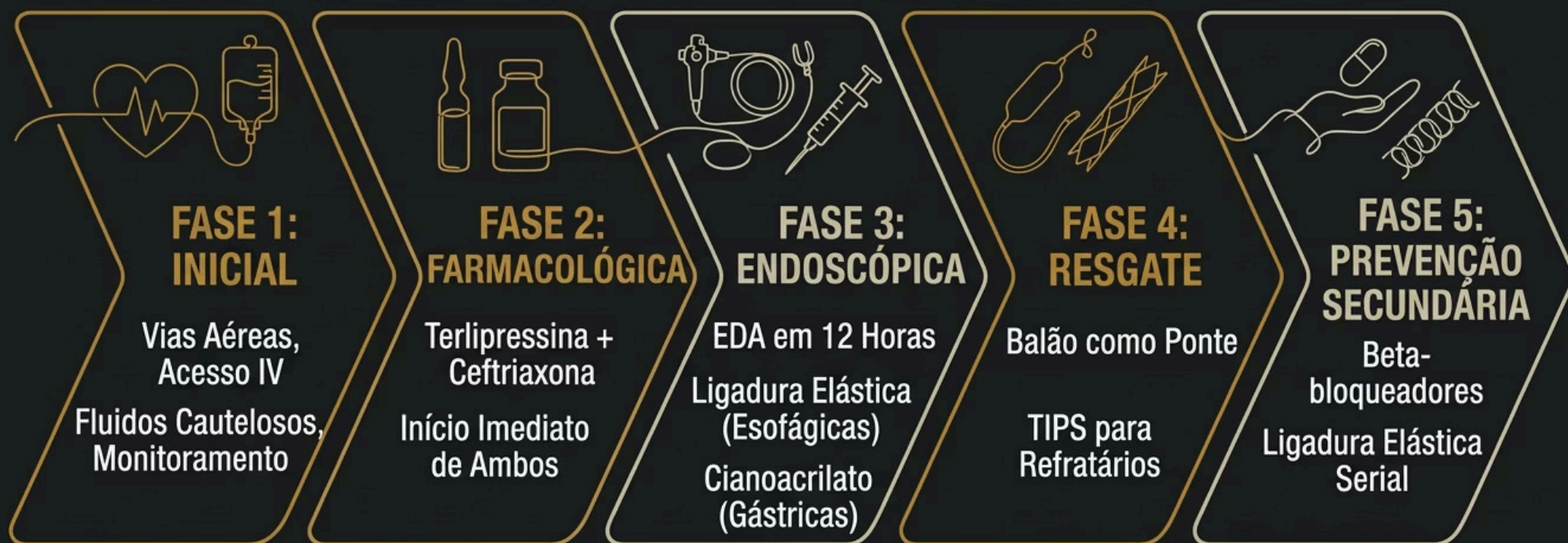
Endoscopia de controle, vigilância de varizes, exames periódicos, transplante hepático em candidatos elegíveis.

Síntese dos Principais Medicamentos e Doses

Referência rápida para uso em emergência — doses e indicações dos principais fármacos utilizados no manejo da hemorragia digestiva:

Fármaco	Indicação	Dose	Duração
Terlipressina	HDA varicosa	2 mg IV bolus a cada 4–6h; reduzir para 1 mg após controle	2–5 dias
Octreotídeo	HDA varicosa	50 mcg IV bolus + 25–50 mcg/h infusão contínua	2–5 dias
Ceftriaxona	Profilaxia bacteriana	1 g IV a cada 24h	5–7 dias
Norfloxacino	Profilaxia bacteriana	400 mg VO 12/12h	7 dias
Pantoprazol	HDA não varicosa	80 mg IV bolus + 8 mg/h infusão	72h IV; depois VO
Propranolol	Profilaxia 1ª e 2ª	10–40 mg VO 12/12h; titular FC 55–60 bpm	Indefinida
Carvedilol	Profilaxia 1ª e 2ª	6,25 mg VO 12/12h; titular conforme tolerância	Indefinida

Infográfico Integrado — HDA Varicosa: Do Diagnóstico ao Tratamento



Este fluxo resume a abordagem escalonada e integrada da HDA varicosa, desde a chegada do paciente ao pronto-socorro até a alta hospitalar com profilaxia secundária instituída. Cada fase deve ser concluída ou em andamento antes de avançar para a próxima.

Quadro Comparativo — HDA vs. HDB vs. HDM

Característica	HDA	HDB	HDM
Localização	Acima do ângulo de Treitz	Cólon e reto	Intestino delgado
Apresentação típica	Hematêmese, melena	Hematoquezia	Melena, sangramento obscuro
Causas principais	Úlcera péptica, varizes	Diverticular, angiodisplasia	Angiodisplasia, GIST, Crohn
Exame diagnóstico	EDA (≤12–24h)	Colonoscopia (≤24h)	Cápsula endoscópica
Tratamento endoscópico	Ligadura, clips, IBP	Clips, APC, coagulação	Enteroscopia terapêutica
Medida específica	Vasoativo + antibiótico (varicosa)	Preparo intestinal prévio	Enteroscopia guiada por cápsula
Resgate/falha	Balão + TIPS	Angioembolização, cirurgia	Cirurgia, angiografia

Conclusão Integrada — O Que o Especialista Precisa Dominar

Dominar hemorragia digestiva é muito mais do que memorizar condutas. Exige a integração harmônica de três dimensões que se completam:

Conhecimento Técnico

Fisiopatologia da hipertensão portal, classificações de risco (Child-Pugh, Forrest, AIMS65), farmacodinâmica dos vasoativos, técnicas endoscópicas (ligadura, cianoacrilato, APC, clips), indicações de TIPS, cápsula endoscópica e enteroscopia. Base insubstituível que fundamenta toda decisão.

Raciocínio Rápido

Capacidade de integrar dados clínicos, laboratoriais e endoscópicos em segundos para definir a estratégia mais adequada. Reconhecimento de padrões, antecipação de complicações e decisão sobre escalonamento terapêutico antes do deterioramento clínico.

Execução Precisa

Habilidade técnica endoscópica, capacidade de liderança da equipe multidisciplinar, comunicação clara com familiares e capacidade de operar sob pressão em cenários de emergência real. A excelência na execução é o que converte o conhecimento em vidas salvas.

Síntese Final — Abordagem de Nível Especialista

A abordagem da hemorragia digestiva de excelência, conforme preconizado pelo curso de especialização, deve reunir quatro atributos fundamentais que se traduzem em desfechos superiores para os pacientes:

1

Executada com Rapidez

Cada hora conta. Vasoativo, antibiótico, EDA — tudo deve ser iniciado o mais precocemente possível.

2

Orientada por Evidência

Diretrizes Baveno VII, ACG e ESGE são a referência. Cada conduta deve ter fundamentação baseada em dados de alta qualidade.

3

Baseada em Risco

Estratificação com escores validados orienta a urgência, o nível de cuidado (UTI vs. enfermaria) e a intensidade da profilaxia.

4

Estruturada e Sistematizada

Protocolos claros, fluxo mental definido, equipe treinada. A estrutura elimina a variabilidade que mata pacientes.

Pontos-Chave para a Prova e para a Prática

Resumo dos conceitos com maior probabilidade de cair em provas de especialização e com maior relevância na prática clínica diária:

→ Terlipressina = único vasoativo com evidência de redução de mortalidade

Iniciar imediatamente na suspeita de HDA varicosa, antes da endoscopia. Manter por 2–5 dias.

→ Antibioticoprofilaxia é universal em cirróticos com sangramento

Ceftriaxona IV é a primeira escolha atual. Não aguardar confirmação endoscópica para iniciar.

→ Transfusão restritiva salva vidas em HDA varicosa

Meta: Hb 7–9 g/dL. Transfusão liberal aumenta pressão portal e ressangramento — evidência nível A.

→ Ligadura elástica para varizes esofágicas; cianoacrilato para gástricas

A troca inadvertida dos métodos é erro técnico grave com impacto direto na eficácia e segurança.

→ TIPS precoce em Child B com sangramento ativo ou Child C até 13 pontos

Evidência nível A para TIPS dentro de 72h nesse perfil. Reduz mortalidade em comparação ao tratamento convencional.

→ Cápsula endoscópica = primeira linha para HDM (sangramento obscuro)

Rendimento máximo quando realizada nas primeiras 48–72h após o sangramento. Guia enteroscopia posterior.

Referências e Diretrizes Utilizadas

Este material foi elaborado com base nas principais diretrizes e publicações científicas internacionais de referência na área de hemorragia digestiva:

Baveno VII Consensus (2022)

European Association for the Study of Liver (EASL). Principal diretriz global sobre hipertensão portal e HDA varicosa. Recomendações sobre TIPS precoce, profilaxia, transfusão restritiva e antibioticoprofilaxia.

ACG Clinical Guidelines — GI Bleeding (2023)

American College of Gastroenterology. Diretrizes abrangendo HDA não varicosa, HDB e sangramento obscuro. Recomendações sobre tempo de endoscopia, preparo colonoscópico e estratificação de risco.

ESGE Guidelines

European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Diretrizes específicas sobre técnicas endoscópicas (ligadura, cianoacrilato, clips, APC), cápsula endoscópica e enteroscopia para sangramento obscuro.

Villanueva et al., NEJM 2013

Estudo seminal randomizado que estabeleceu a superioridade da estratégia transfusional restritiva (Hb 7 g/dL) sobre a liberal na HDA. Referência obrigatória para qualquer prova de especialização.

Parabéns pela Conclusão do Módulo 3

Você concluiu a Parte 3 da apostila de Hemorragia Digestiva — um dos temas mais desafiadores e clinicamente relevantes da gastroenterologia e da medicina de urgência. O domínio desse conteúdo é diretamente proporcional à capacidade de salvar vidas em situações de alta pressão.

O Que Você Estudou

- HDA varicosa: fisiopatologia, classificação de risco, tratamento farmacológico e endoscópico
- Terapia vasoativa e antibioticoprofilaxia universal
- TIPS, balão de Sengstaken e falha terapêutica
- HDB: causas, colonoscopia e hemostasia
- HDM: cápsula e enteroscopia
- Casos clínicos e raciocínio avançado do especialista

Próximos Passos

- Revisar as classificações de risco (Child-Pugh, Forrest, AIMS65)
- Praticar com casos clínicos adicionais
- Ler as diretrizes Baveno VII na íntegra
- Discutir casos reais com seu preceptor/supervisor